

1. Накладання коміру Шанца

Сценарій.

Ви черговий лікар, до приймального відділення вашої лікарні самостійно звернувся пацієнт 32 років зі *скаргами*: на помірний біль у шиї, обмеженість і болючість рухів головою, неможливість тримати голову «прямо».

Анамнез захворювання: Травма побутова, годину тому бід час ігрової боротьби з дітьми з необережності впав з висоти власного зросту та вдарився головою. Після чого відчув сильний біль у шиї, з'явилося обмеження руху головою. Вживання алкоголю та наркотиків заперечує. Особистим авто доїхав до лікарні.

Анамнез життя: В минулому здоровий. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена.

Об'єктивно: Стан задовільний. Свідомість збережена. Голова знаходиться в вимушеному положенні з нахилом вліво та вниз, неможливий активний поворот голови праворуч. При спробі пасивного повороту голови (через силу), з'являються різкі больові відчуття.

Пальпація ділянки шиї прилеглої до черепа в проекції хребців викликає біль. Гіпертонус задньої групи шийних м'язів. Шкіра звичайного забарвлення, волога. Зріст 166 см, вага 73 кг. Периферичний набряків немає. Тони серця ясні, ритмічні, патологічних шумів немає. ЧСС 98 за хв., АТ 110/70 мм рт.ст., При аускультатії легень дихання вислуховується над всіма легеневидами полями, ЧДР 16 за хв. Живіт нероздутий, приймає участь у акті дихання. При пальпації м'який безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги.

Симптом Щоткіна-Блюмберга негативний. Аускультативно - перистальтика вислуховується. Симптом Пастернацького негативний з обох боків. Сечовипускання та дефекація не порушені.

Неврологічний статус. Активні та пасивні рухи, м'язова сила та чутливість у верхніх та нижніх кінцівках у збережені у повному обсязі, патологічних рефлексів не виявлено.

Додатково:

Клінічний аналіз крові

Показник	Значення	Референтні значення
Гемоглобін г/л	138	130-160г/л – для чоловіків 120-140г/л - для жінок
Еритроцити $10^{12}/л$	4,1	$4,0-5,0 \times 10^{12}/л$ – для чоловіків $3,9-4,7 \times 10^{12}/л$ – для жінок
Кольоровий показник	0,9	0,85-1,15
Тромбоцити $10^9/л$	110	$180-320 \times 10^9/л$

4

Лейкоцити $10^9/л$	19,0	$4,0-9,0 \times 10^9/л$
- лімфоцити%	21	19-37%
- еозінофіли %	3	0,5-5,0%
- палочкоядерні нейтрофіли %	11	0-5,0%
- сегментоядерні нейтрофіли %	69	47,0-72,0%
- моноцити %	5	3,0 – 11,0 %
ШОЕ	10	1 – 10 мм/ч – для чоловіків 2 – 15 мм/ч – для жінок

Клінічний аналіз сечі

Показник	Значення	Референтні значення
Колір - жовта	жовта	різні відтінки жовтого кольору
Прозорість	прозора	прозора;
Реакція	кисла	pH менше 7
Питома вага	1015 г / л	1,012 г / л – 1,022 г / л
Лейкоцити	1 -2 в полі зору.	0-6 в полі зору для жінок; 0-3 в полі зору для чоловіків;
Епітелій плоский	13-14 в полі зору.	0-10 в полі зору.
Білок	відсутній	відсутній
Еритроцити	0-1 в полі зору,	0-3 в полі зору для жінок; 0-1 в полі зору для чоловіків;
Слиз	відсутня	відсутня
Солі	відсутні	відсутні
Глюкоза	відсутня	відсутня
Циліндри	відсутні	відсутні

Рентгенограма шийного відділу хребта (прямий знімок через розкритий рот).



12. Інструкція для стандартизованого пацієнта (за необхідності, якщо це передбачено умовами роботи на станції).

№п/п	Дії	Текст
1.Комунікативні навички		
1.1	Привітатися.	Доброго дня.
1.2	Ви даєте свою згоду на проведення клінічного обстеження?	Так
Збір скарг та анамнезу		
2.1	Які у Вас скарги?	на помірний біль у шиї, обмеженість і болючість рухів головою, неможливість тримати голову «прямо».
2.2	Коли з'явилися скарги, що з Вами трапилось?	годину тому під час ігрової боротьби з дітьми з неосторожності впав з висоти власного зросту

		та вдарився головою, відчув сильний біль у шийі, з'явилося обмеження руху головою
2.3	Якими захворюваннями перехворіли? Чи є алергія? Чи були операції?	Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Огляд з верифікацією виявлених патологічних змін. Оцінка неврологічного статусу.	Я провожу огляд з верифікацією виявлених патологічних змін . Я виявляю вимушене положення голови з нахилом вліво та вниз. Обличчя симетричне, шкірні покриви звичайного забарвлення, голова утримується пацієнтом руками через болючість. Неврологічний статус – все в нормі.
3.2	Пальпація з верифікацією виявлених патологічних змін	Я провожу пальпацію з верифікацією виявлених патологічних змін. Я обережно палькую шийний відділ хребта — в проекції верхніх шийних хребців виявляється болючість. Також спостерігається гіпертонус задньої групи шийних м'язів, що підтверджує травматичне ушкодження
3.3	Перкусія з верифікацією виявлених патологічних змін	Я провожу перкусію з верифікацією виявлених патологічних змін . Я здійснюю обережну перкусію шийного відділу хребта — локальна болючість в ділянці С1–С2, без іррадіації, без додаткових патологічних звуків.
3.4	Аускультация з верифікацією виявлених патологічних змін	Я провожу аускультацию з верифікацією виявлених патологічних змін. Я вислуховую везикулярне дихання в обох легених полях, серцеві тони ясні, ритмічні. Аускультативно патологічних змін не виявлено.
4.Діагностика		
4.1	Проаналізувати клінічний аналіз крові	Я аналізую клінічний аналіз крові та сечі. Я бачу лейкоцитоз ($19,0 \times 10^9/\text{л}$), підвищений рівень паличкоядерних нейтрофілів, що вказує на запальну реакцію після травми. Тромбоцитопенія ($110 \times 10^9/\text{л}$) потребує контролю. В сечі — незначна кількість епітелію (13–14), інші показники в нормі.

4.2	Проаналізувати оглядову рентгенографію органів грудної клітини	Я аналізую рентгенограму шийного відділу хребта. Я виявляю ротаційне зміщення атланта (C1) без ознак перелому. Порушення симетрії суглобових щілин між атлантом та аксисом — підтверджує діагноз.
4.3	Встановити попередній клінічний діагноз	Ротаційний підвивих атланта (C1) після побутової травми
5. Визначення тактики ведення та лікування		
5.1	Медикаментозна терапія, фізіотерапія, особливості харчування	Я негайно накладаю шийний комір Шанца для іммобілізації та запобігання ускладнень. Призначаю знеболювальні препарати (НПЗП – диклофенак в/м 3мл), м'язові релаксанти. Рекомендую щадний режим, контроль неврологічного статусу, консультацію нейрохірурга. Фізіотерапія — після стабілізації. Харчування — звичайне, багате на білки та мікроелементи.
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6.1	Рекомендувати профілактичні заходи	Я рекомендую уникати різких рухів головою, не займатися самостійним вправлянням хребців. У майбутньому — регулярні заняття лікувальною фізкультурою, укріплення м'язового каркасу шиї, профілактика повторних травм.
7.Інше		
7.1	Інформування пацієнта про можливі ризики хвороби	Я інформую пацієнта про можливі ризики травми . Я поясню пацієнту ризики ускладнень — пошкодження спинного мозку, стійкий больовий синдром, неврологічні порушення. Надаю повну інформацію про необхідність дотримання лікувального режиму та повторного огляду.

Чек-лист до практичної навички «Накладання коміру Шанці»

№ п/п	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, провести	Сказати

	огляд постраждалого, визначити наявність свідомості та дихання.	
2	Встановлення контакту з пацієнтом. Привітатись, представитися, позначити свою роль. Попросити пацієнта представитися. Визначити особливості анамнезу (механізм травми, алергічні реакції на ліки)	Сказати
3	Отримати інформаційну згоду на проведення маніпуляції (пояснити хід та мету процедури)	Сказати
4	Одягнути медичні діагностичні рукавички.	Виконати
5	Оглянути місце травми для визначення характеру ушкодження (обережно, не повертаючи голову пацієнта)	Виконати, Сказати.
6	Підготувати комір Шанца до накладення, розгорнувши його	Виконати,
7	Осушити та очистити шкіру пацієнта в області шиї серветкою з антисептиком (обережно)	Виконати, Сказати
8	Коректно та обережно встановити комір проводячи його рукою під шиєю так, щоб нижній край коміра спереду був на рівні ключиць, а верхній вирізкою на рівні підборіддя. Ззаду шия повинна знаходитися на середині коміра, а верхній край коміра знаходиться під потилицею. Нижній край коміра знаходиться під трапецієвидним м'язом.	Виконати
9	Перевірити правильність накладання: між коміром та шиєю пацієнта має проходити палець. Зафіксувати застібками.	Виконати, Сказати
10	Повідомити хворого про результати іммобілізації та подальші дії	Сказати
11	Уточнити у пацієнта його самопочуття (у т.ч. рухливість та чутливість кінцівок).	Сказати
12	Запропонувати пацієнтові залишитися у зручному положенні на кушетці.	Сказати
13	Завершення процедури	Сказати